

B13 :Hypothyroïdie Auto-immune Sévère : de la Crise Métabolique à la Normalisation Spectaculaire sous Traitement



S. BOUAM (1)
(1) Laboratoire de Biochimie-Hormonologie, EPH-1 Arris, Batna, Algérie

Introduction

L'hypothyroïdie primaire auto-immune (Thyroïdite de Hashimoto) peut, en l'absence de diagnostic précoce, évoluer vers un tableau d'hypométabolisme systémique sévère mimant un syndrome métabolique complet.

Le dosage de la TSH constitue l'outil de dépistage de première intention, dont la valeur prédictive est illustrée dans ce cas clinique exceptionnel.

Message clé

Devant toute dyslipidémie sévère ou cytolyse inexpliquée chez le sujet jeune, penser systématiquement à doser la TSH.

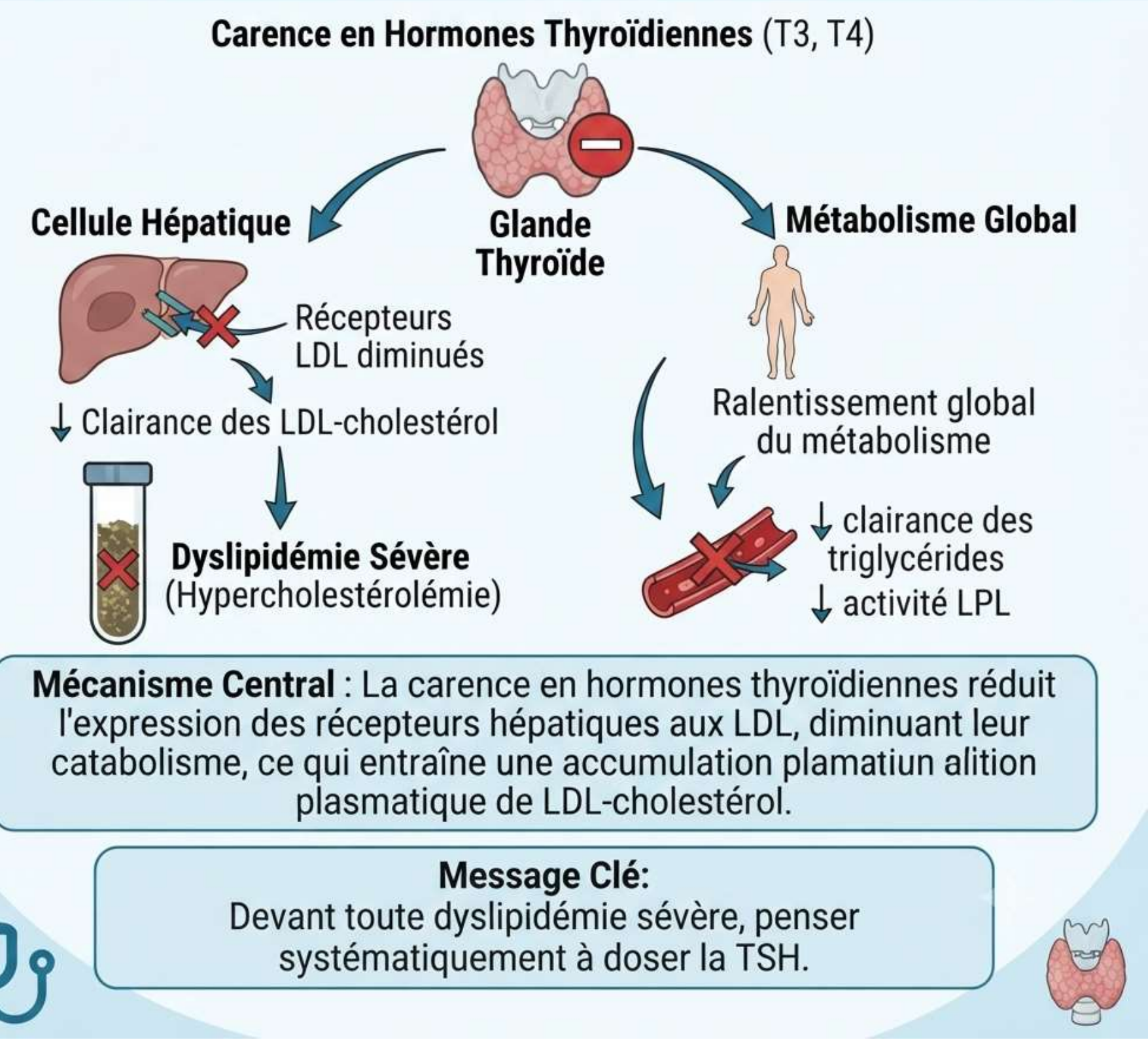
Objectif

Illustrer, à travers un cas clinique, l'ampleur du syndrome pluri-métabolique secondaire que peut engendrer une hypothyroïdie auto-immune sévère méconnue, et sa réversibilité complète sous traitement substitutif.

Physiopathologie

Le ralentissement global du métabolisme induit par la carence en hormones thyroïdiennes diminue la clairance des lipoprotéines de basse densité (LDL) par réduction de l'expression des récepteurs hépatiques, expliquant la dyslipidémie secondaire et sa réversibilité rapide sous hormonothérapie substitutive.

Physiopathologie de l'Hypothyroïdie Sévère et Dyslipidémie



Action sur l'ADN Nucléaire

La T3 se lie aux récepteurs nucléaires pour moduler directement l'expression transcriptionnelle des gènes cibles.

Conclusion

Ce cas illustre la capacité de l'hypothyroïdie auto-immune à masquer un syndrome pluri-métabolique complexe et souligne l'importance du dosage systématique de la TSH devant toute dyslipidémie sévère ou cytolyse inexpliquée chez le sujet jeune. La substitution hormonale constitue à elle seule le traitement étiologique de l'ensemble des anomalies biologiques : traiter la cause supprime toujours le traitement des conséquences.

Observation Clinique

Patiente de 25 ans, sans antécédents

Consultant pour : asthénie majeure, bradypsychie, frilosité, oedèmes myxoedémateux des membres inférieurs.

Bilan biologique — avant / après traitement

Paramètre	Avant ttt	Après ttt (S7)	Valeurs usuelles
TSHus (mUI/L)	310*	5,07	0,27 – 4,20
FT4 (pmol/L)	Indécelable	19,17	12 – 22
FT3 (pmol/L)	1,01	–	3,1 – 6,8
Anti-TPO	Fortement +	–	Négatif
Cholestérol total (g/L)	6,87	1,27	< 2,00
LDL-cholestérol (g/L)	5,52	0,94	< 1,60
ASAT (UI/L)	70	–	< 40
ALAT (UI/L)	46	–	< 41

*Après dilution. S7 = contrôle à 7 semaines de traitement.

Traitement instauré

Lévothyroxine 100 µg/j associée à l'atorvastatine.

Contrôle biologique programmé à 7 semaines.

Conclusion diagnostique : Thyroïdite de Hashimoto évoluée avec dyslipidémie mixte sévère et cytolys hépatique modérée, secondaires au ralentissement du catabolisme des lipoprotéines.

Particularité du cas

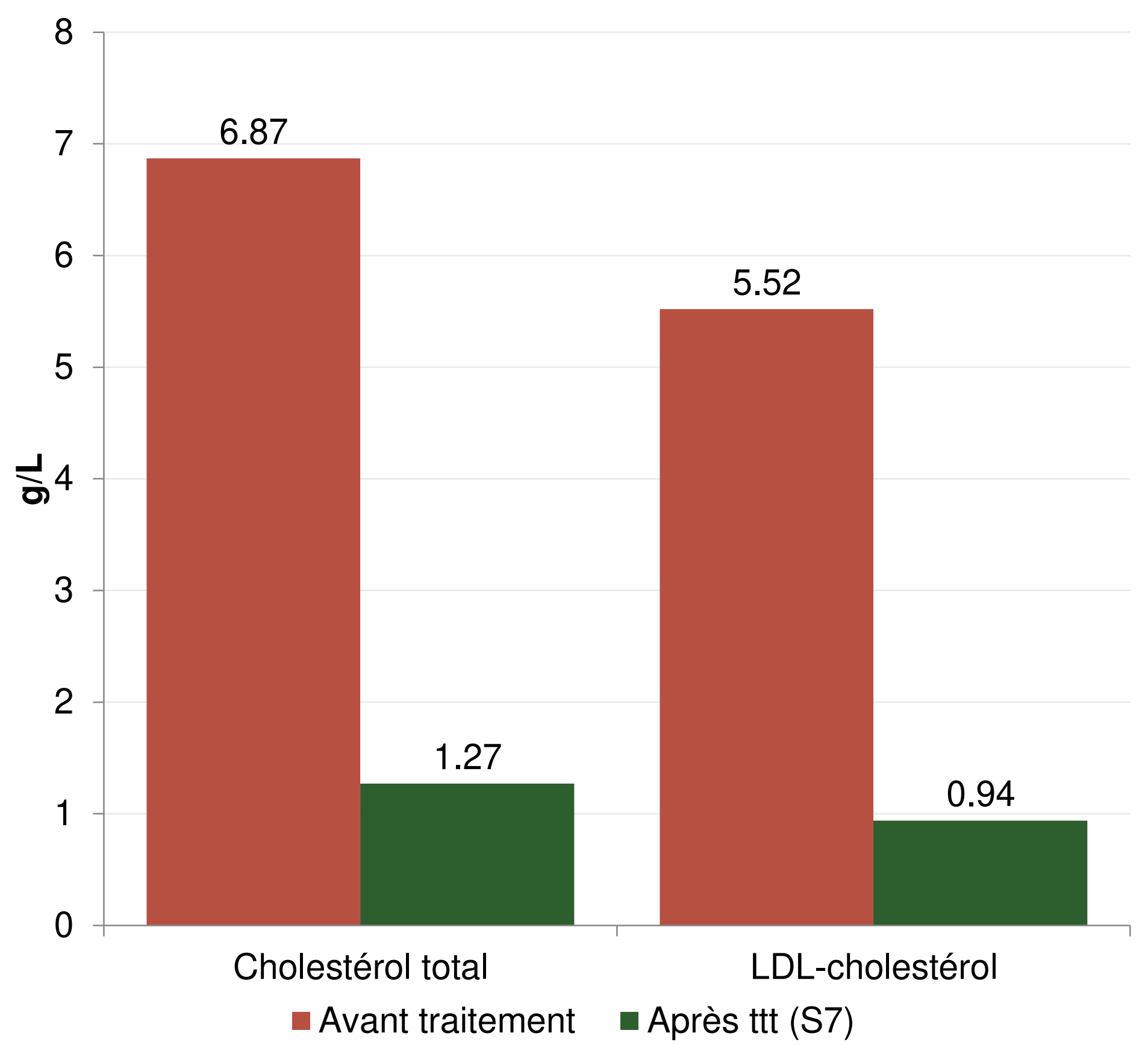
L'ampleur de l'élévation du LDL (5,52 g/L) et le degré de cytolys hépatique observés font partie des présentations les plus sévères rapportées pour une hypothyroïdie décompensée chez une patiente jeune sans comorbidité connue.

Discussion

Après instauration du traitement substitutif, le contrôle à 7 semaines montre une normalisation spectaculaire du bilan thyroïdien et une réduction lipidique de plus de 80 %, confirmant le caractère purement secondaire de la dyslipidémie.



Évolution du bilan lipidique (g/L)



La réversibilité quasi complète du profil lipidique sous simple substitution hormonale confirme l'absence de dyslipidémie primitive associée.

Comparaison avec les données de la littérature :

Nos résultats concordent avec les études internationales soulignant le rôle crucial des hormones thyroïdiennes dans le métabolisme lipidique : **Régulation hépatique :** La littérature établit que la carence en hormones thyroïdiennes diminue l'expression des récepteurs hépatiques aux LDL, prolongeant ainsi leur demi-vie plasmatique. Une étude marquante de Duntas *et al.* (2018) confirme cette corrélation directe : ils ont démontré que dans les cas d'hypothyroïdie sévère, le taux de cholestérol augmente significativement en raison de cette réduction de la clairance des lipoprotéines [1]. **Sévérité du tableau :** Alors que les dyslipidémies modérées sont classiques, le cas présenté se distingue par une élévation du LDL-cholestérol (5,52 g/L) particulièrement élevée, illustrant une forme de décompensation sévère rarement décrite chez une patiente jeune sans comorbidités préexistantes **Cytolyse hépatique :** L'association avec une cytolys modérée est documentée comme une manifestation rare mais spécifique de l'hypothyroïdie sévère, souvent réversible sans hépatotoxicité résiduelle après équilibration hormonale [cite: 2].